



**Universidad
Norbert Wiener**

Powered by **Arizona State University**

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

Escuela Académico Profesional de Enfermería

**Nivel de conocimiento y su relación con el cumplimiento del uso
de la vacuna neumocócica en el Servicio de Inmunización del
adulto mayor del Centro de Salud Breña Lima 2025**

**TRABAJO ACADÉMICO PARA OPTAR EL TÍTULO DE LICENCIADO EN
ENFERMERIA**

Presentado por:

AUTOR: TORRES BELLIDO Jimmy Jorge

CODIGO ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-7446-1619>

ASESOR: MG. MORI CASTRO Jaime Alberto

CODIGO ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2570-0401>

LIMA – PERÚ

2025

DEDICATORIA:

A todos los enfermeros que dieron la vida por salvar a
quienes en su agonía aclamaron por ayuda en el campo
de batalla durante el tiempo de guerra

AGRADECIMIENTO:

A quienes en todo momento me acompañaron y creyeron en mi esfuerzo, sin duda saben que fue mi mayor logro, a mi familia...

ASESOR DE TESIS: MG. MORI CASTRO JAIME ALBERTO

JURADO

Presidente: Mg.

Secretario: Mg.

Vocal: Mg.

ÍNDICE

CAPITULO I. EL PROBLEMA	11
1.1. Planteamiento del problema	11
1.2. Formulación del problema	13
1.2.1. Problema general	13
1.2.2. Problemas específicos	13
1.3. Objetivos de la investigación	14
1.3.1. Objetivo general	14
1.3.2. Objetivos específicos	14
1.4. Justificación de la investigación	15
1.4.1. Teórica	15
1.4.2. Metodológica	15
1.4.3. Práctica	15
CAPITULO II. MARCO TEÓRICO	17
2.1. Antecedentes	17
2.2. Base Teórica	21
2.3. Formulación de hipótesis	32
2.3.1. Hipótesis general	32
2.3.2. Hipótesis específica	32
CAPITULO III METODOLOGÍA	33
3.1. Método de la investigación	33
3.2. Enfoque de la investigación	33
3.3. Tipo de investigación	33
3.4. Diseño de la investigación	34
3.5. Población, muestra y muestreo	34
3.6. Variables y operacionalización	37
3.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos	39
3.7.1. Técnica	39
3.7.2. Descripción de instrumentos	39
3.7.3. Validación	40
3.7.4. Confiabilidad	40
3.8. Plan de procesamiento y análisis de datos	40
3.9. Aspectos éticos	41

REFERENCIAS

Anexos

Instrumento de medición

Consentimiento informado

Matriz de consistencia

Resumen

Objetivo: Analizar la relación del nivel de conocimiento con el cumplimiento del uso de la vacuna neumocócica en el Servicio de Inmunización del adulto mayor del Centro de Salud Breña Lima 2025. **Metodologías:** Mediante enfoques del estudio cuantitativos, aplicados, no experimentales, correlacionales, transversales; El trabajo tiene muestreos no probabilísticos, se han trabajado con 180 adultos mayores. El estudio seleccionará sistemáticamente a 144 adultos mayores del Centro de Salud Breña. **Resultados.** Se tiene niveles de conocimientos dimensión esquema de vacunación El nivel de conocimiento con cumplimientos del uso de la vacuna neumocócica, hay nivel de conocimiento medio con lo que no cumple con el uso de la vacuna neumocócica en 75%. En la dimensión definiciones de la vacuna antineumocócica de la tabla 4 con el cumplimiento del uso de la vacuna neumocócica, hay nivel de conocimiento medio con lo que no cumple con el uso de la vacuna neumocócica en 61.8%. En la dimensión esquema de Inmunizaciones de la vacuna antineumocócica en el adulto mayores de la tabla 5 con el cumplimiento del uso de la vacuna neumocócica, hay nivel de conocimiento medio con lo que no cumple con el uso de la vacuna neumocócica en 47.9%. En la dimensión medidas ante las reacciones adversas de la vacuna Antineumocócica de la tabla 6 con el cumplimiento del uso de la vacuna neumocócica, hay nivel de conocimiento medio con lo que no cumple con el uso de la vacuna neumocócica en 61.1%.

Palabras claves: Nivel de conocimiento, cumplimiento, vacuna neumocócica.

Abstract

Objetivo: Analizar la relación del nivel de conocimiento con el cumplimiento del uso de la vacuna neumocócica en el Servicio de Inmunización del adulto mayor del Centro de Salud Breña Lima 2025. **Metodologías:** Mediante enfoques del estudio cuantitativos, aplicados, no experimentales, correlacionales, transversales; El trabajo tiene muestras no probabilísticas, se han trabajado con 180 adultos mayores. El estudio seleccionará sistemáticamente a 144 adultos mayores del Centro de Salud Breña. **Resultados.** Se tiene niveles de conocimientos dimensión esquema de vacunación El nivel de conocimiento con cumplimientos del uso de la vacuna neumocócica, hay nivel de conocimiento medio con lo que no cumple con el uso de la vacuna neumocócica en 75%. En la dimensión definiciones de la vacuna antineumocócica de la tabla 4 con el cumplimiento del uso de la vacuna neumocócica, hay nivel de conocimiento medio con lo que no cumple con el uso de la vacuna neumocócica en 61.8%. En la dimensión esquema de Inmunizaciones de la vacuna antineumocócica en el adulto mayor de la tabla 5 con el cumplimiento del uso de la vacuna neumocócica, hay nivel de conocimiento medio con lo que no cumple con el uso de la vacuna neumocócica en 47.9%. En la dimensión medidas ante las reacciones adversas de la vacuna Antineumocócica de la tabla 6 con el cumplimiento del uso de la vacuna neumocócica, hay nivel de conocimiento medio con lo que no cumple con el uso de la vacuna neumocócica en 61.1%.

Keywords: Level of knowledge, compliance, pneumococcal vaccine.

CAPITULO I. EL PROBLEMA

1.1. Planteamiento del problema

La OMS (Organización Mundial de la Salud) en 2020 afirma que la inmunización es un modelo para la salud y desarrollo globales, que salva millones de vidas al año. Actualmente, las vacunas previenen más de 20 enfermedades mortales y ayudan a personas de todas las edades a vivir una vida más larga y saludable. Actualmente, la inmunización previene cada año entre 2 y 3 millones de muertes por esta enfermedad que alguna vez fue mortal (1).

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), dice que de 2 a 3 millones desarrollaron cada año mejor inmunidad a varias enfermedades gracias a las vacunas constante. Entre 2017 y 2021, 1,723 millones de neonatos no recibieron las primeras dosis de la vacunas de sarampión. La desconfianza de los padres o falta de comprensión de vacunas, aumentan posibilidades de recurrencia del sarampión (2).

Sin embargo, en América Latina el alcance de la vacunación varía por tipos de enfermedades. Según la (OPS) Organización Panamericana de la Salud, mientras que la cobertura de vacunación contra la tuberculosis fue la más alta con un 94% en 2019, la cobertura de vacunación contra la difteria, el tétanos y la tos ferina fue la más baja con un 77% (3).

En el contexto, estudio con 500 padres en Ecuador halló que el 64% tenían conocimientos, el 74% tenían actitudes positivas y 55% con práctica adecuada en vacunación (4).

Caso especial para las vacunas infantiles en febrero del 2022, la OPS pidió redoblar esfuerzos en la vacuna del niño para polio, con coberturas de vacunación de 3 dosis de 84%. África fue declarado libre de la enfermedad en 1994 y ahora está en nivel más bajo. Si la vacunación en cada comunidad no supera 95%, la polio puede causar enfermedad paralizante. En 2020, 12 países tienen cobertura inferior al 81% con la tercera dosis (5).

El impacto de la pandemia en la inmunización resultó 17% menos de niños menores de 12 años en 2020 respecto al 2019, el Ministerio de Salud (Minsa) implementa planes para cerrar la brecha de vacunación que reduce propagación de enfermedades de niños de edades medias a menores de 12 años, la edad de riesgo es 12 años (6).

También en 2020, el Instituto de Investigaciones Económicas del Perú informó la caída en la cobertura de vacunas y niveles máximos 2021 por problema en medida pandémica. Las tasas de vacunación fueron 41% en septiembre, en comparación con una tasa de cobertura esperada del 70%. La ratio de cobertura de precios de cinco proyectos cayó a 0,9% en abril y ha mejorado desde entonces, pero no ha alcanzado el promedio del año pasado del 7%. La tendencia es evidente en la baja de cobertura de otras vacunas esenciales, excepto la vacuna contra la tuberculosis, que se coloca al nacer (7).

Un trabajo de 2021 encontró que ciertos factores están asociados con el incumplimiento del calendario de vacunación, como la edad materna, atención prenatal inadecuada, etc. (8).

Estudio de 2021 encontró que las madres que no tienen seguro médico, viven en pobreza, con problemas en llegar a centros médicos, no son hispanas y otras de incumplimiento (9).

Trabajos del 2020, donde 54,85% para la prueba se utiliza en diagnósticos. De 25% no estaban vacunados con vacunas de la tos ferina, el 97,11% tenían menos de seis meses, el 43% tenían menos de tres meses y 11% estaban en cuidado intensivo. Luego, una persona murió, indicando la importancia preventiva de vacunación infantil (10).

El trabajo realizado en el Centro de Salud Breña Lima demostró que las madres no sabían sobre la vacunación de sus hijos y tenían preocupaciones sobre efectos secundarios, algunas se preocupaban por vacunar a sus hijos. La vacunación puede ser perjudicial en la salud del

adulto mayor, es importante comprender los factores asociados al cumplimiento de calendarios de vacunación en mejorar la inmunidad.

1.2. Formulación del problema

1.2.1. Problema general

¿Cuál es la relación del nivel de conocimiento con el cumplimiento del uso de la vacuna neumocócica en el Servicio de Inmunización del adulto mayor del Centro de Salud Breña Lima 2025?

1.2.2. Problemas específicos

- ¿Cuál es la relación del nivel de conocimiento en su dimensión definiciones de la vacuna antineumocócica con el cumplimiento del uso de la vacuna neumocócica en el Servicio de Inmunización del adulto mayor del Centro de Salud Breña Lima 2025?
- ¿Cuál es la relación del nivel de conocimiento en su dimensión esquema de Inmunizaciones de la vacuna antineumocócica en el adulto mayores con el cumplimiento del uso de la vacuna neumocócica en el Servicio de Inmunización del adulto mayor del Centro de Salud Breña Lima 2025?
- ¿Cuál es la relación del nivel de conocimiento en su dimensión medidas ante las reacciones adversas de la vacuna Antineumocócica con el cumplimiento del uso de la vacuna neumocócica en el Servicio de Inmunización del adulto mayor del Centro de Salud Breña Lima 2025?

1.3. Objetivos de la investigación

1.3.1. Objetivo general

Analizar la relación del nivel de conocimiento con el cumplimiento del uso de la vacuna neumocócica en el Servicio de Inmunización del adulto mayor del Centro de Salud Breña Lima 2025

1.3.2. Objetivos específicos

- Determinar la relación del nivel de conocimiento en su dimensión definiciones de la vacuna antineumocócica con el cumplimiento del uso de la vacuna neumocócica en el Servicio de Inmunización del adulto mayor del Centro de Salud Breña Lima 2025
- Determinar la relación del nivel de conocimiento en su dimensión esquema de Inmunizaciones de la vacuna antineumocócica en el adulto mayores con el cumplimiento del uso de la vacuna neumocócica en el Servicio de Inmunización del adulto mayor del Centro de Salud Breña Lima 2025
- Determinar la relación del nivel de conocimiento en su dimensión medidas ante las reacciones adversas de la vacuna Antineumocócica con el cumplimiento del uso de la vacuna neumocócica en el Servicio de Inmunización del adulto mayor del Centro de Salud Breña Lima 2025

1.4. Justificación de la investigación

1.4.1. Teórica

Es de importancia porque ayudara a recopilar informaciones relevantes para tomar medidas y desarrollar medidas para prevenir el daño que causa no vacunar. Este tema es importante

porque la inmunidad es un tema que siempre hay que evaluar porque, si bien ha demostrado ser eficaz para prevenir muchas enfermedades mortales en el pasado, no se ha desarrollado como se esperaba, por lo que existen grandes vacíos en la investigación y generación de conocimiento al respecto. Si bien es esencial centrarse en los sitios de estudio para aumentar la conciencia entre las madres y las instituciones de que es necesario fortalecer las estrategias basadas en el conocimiento materno sobre la adherencia a programas de vacunación, se proporcionará además un análisis de las teorías existentes. Mejorar el conocimiento de las variables de la encuesta. Su finalidad es analizar los niveles de conocimientos en el adulto mayor, conocer cuánto saben sobre la vacunación y qué vacunas deben ponerse, para luego determinar si se están siguiendo la vacunación, es fundamental para prevenir varias enfermedades

1.4.2. Metodológica

Este trabajo tiene solidez metodológica, ya que podría ayudar razonablemente a medir en qué medida el conocimiento del adulto mayor se relaciona con el cumplimiento de la vacunación, lo que se puede lograr mediante cuestionarios y tablas de comparación, según las observaciones. Los problemas se observan de manera más específica y pueden contribuir el desempeño del enfermero en la mejora de estrategia para aumentar los cumplimientos maternos del programa de vacunaciones.

Práctica

Este estudio es importante porque se aplica a vacunas como *Streptococcus pneumoniae*, Rotavirus y otros, Influenza que ayudan a prevenir enfermedades como Hepatitis B, Neumonía, Rotavirus, etc. La diarrea viral, la poliomielitis y las infecciones respiratorias agudas siguen siendo problemas de salud pública a nivel nacional e internacional. Las madres adolescentes son responsables, seguir la vacunación acordado por la enfermera en

cada fecha de vacunación, para prevenir oportunamente diversas enfermedades provocadas por la misma. Cuando entran al cuerpo, causan daño. Los profesionales de la salud a cargo de los dispensarios de vacunación tienen la responsabilidad de registrar e identificar las razones por las cuales no cumplen con la vacuna, deben actuar en base a los resultados que ayudarán a mejorar la vacunación. Permitirá tomar mejores decisiones en los procesos de políticas de salud, implementar intervenciones apropiadas de educación sanitaria y contribuir a mejorar el conocimiento sobre la inmunización.

CAPITULO II. MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes

A nivel internacional:

Ekin y col., (11) en 2023, en Turquía, con el objetivo “Evaluar conocimientos de vacunación antineumocócica (PCV13, PPSV23) en consultas externas de cardiología y el impacto de recomendación en tasas de vacunación”. Estudio, correlacional, prospectivo, observacional. Muestra de 400 pacientes. Método, usaron como instrumento las encuestas. Resultados, el 19% de pacientes con vacunación antineumocócica previa se excluyeron del estudio. El 58% tienen enfermedad coronaria, hipertensión en 74% que es factor de riesgo común y 33% de nunca se vacunaron, pero con información antes de vacunación. Las diferencias de pacientes vacunados y sin vacuna se relaciona con nivel de educación y la fracción de eyección.

Yilmaz y col., (12) en el 2023, en Turquía, con el objetivo “Analizar efectos de vacunas neumocócicas, antigripales y COVID-19 en el estado de la hospitalización y la progresión de COVID-19”. Estudio, correlaciona, descriptivo. Muestra de 200 personas mayores de 65 años que viven en hogares de ancianos. Metodo, usaron como instruymiento las encuestas. Resultados, la tasa de diagnóstico de COVID-19 fue 49%, tasa de hospitalización 24%, tasa de hospitalización en UCI 12%. La tasa de intubación fue 11%, tasa de ventilación mecánica 12%, tasa de mortalidad en relacion COVID-19 7%. Los factores que afectan diagnóstico de COVID-19, dosis de vacuna COVID-19 es protectora. Factores de afecto de hospitalización, y enfermedades crónicas fueron factores de riesgo; cuatro dosis de vacuna COVID-19 y vacuna de influenza y vacuna neumocócica junto con vacuna COVID-19 fueron protectoras.

Suitner y col., (13) en el 2022, en Italia, con el objetivo “Analizar al *Streptococcus pneumoniae* como la principal causa de muerte por neumonía, especialmente entre las

personas mayores, siendo la vacuna el principal instrumento de prevención”. Estudio, correlacional, no experimental, cuantitativo. Muestra de 600 pacientes. Método, realizó una encuesta a una muestra representativa de italianos mayores de 65 años. Resultado, es bajo el estado de vacunación informado 12%, los encuestados no se informan sobre la oportunidad de vacunación. La fuente de información eficaz son proveedores de atención médica, y que la vacilación ante las vacunas se relaciona positiva con percepción de riesgo relacionada con la enfermedad y negativa con percepción de riesgo de reacciones adversas a vacunas.

Fuller (14), en 2024, en Estados Unidos, con el objetivo “Analizar las posibles barreras a la aceptación de las vacunas recomendadas para adultos mayores y considera la variación demográfica y los vínculos con la aceptación de distintas vacunas”. Estudio, correlacional, descriptivo, transversal. Muestra de 900 adultos mayores (de 65 años o más) en todo el estado de Dakota del Norte. Método, trabajaron mediante encuestas mediante características demográficas, las barreras para la vacunación (incluida la fobia a las agujas, el costo, la falta de recomendación médica, el transporte y la incertidumbre en la programación) y la aceptación de la vacuna (incluida la aceptación y la adopción de las recomendaciones de los proveedores para las vacunas contra la influenza, el herpes zóster, el neumococo y la COVID-19). Resultados, costo 27% y fobia a agujas 24% fueron barreras prevalentes. Los adultos mayores de zonas rurales y viven solos experimentan más riesgos de barreras en costo, transporte y la incertidumbre sobre cómo programar una cita. La fobia a las agujas se asoció con la aceptación de todas las vacunas excepto la COVID-19. La barrera del transporte se asoció con aceptación de vacuna neumocócica.

Kobayashi (15), en 2023, en Estados Unidos, con el objetivo “Analizar las recomendaciones publicadas por el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP) de los CDC para el uso de vacunas antineumocócicas en adultos de 19 años o más en los Estados Unidos”.

Estudio, no experimental, cuantitativo. Muestra de 200 muestras. Método, análisis de casos por versión de datos. Resultado, antes de 2021, ACIP recomendaba vacuna antineumocócica 23-valente (PPSV23) sola (hasta 2 dosis), o dosis única de vacuna antineumocócica 13-valente (PCV13) en combinación con 1 a 3 dosis de PPSV23 serie (PCV13 de PPSV23), uso en adultos según edad y riesgo de enfermedad neumocócica. En 2021, la Administración de Alimentos y Medicamentos autorizó uso de nuevas vacunas antineumocócicas (PCV), una PCV 15-valente y 20-valente (PCV15 y PCV20), para adultos ≥ 18 años.

A nivel nacional:

Canchari (16) en el 2021, mediante el objetivo “Analizar la relación del nivel de conocimiento con la percepción de vacuna antineumocócica en adultos mayores, Hospital Ventanilla”. Estudio, correlacional, cuantitativo, experimental, transversal. Muestra de 30 adultos. Método, utilizaron cuestionario y lista de cotejo. Resultados, hay relación significativa con alfa menor de 0.05 del nivel de conocimiento en percepción de vacuna antineumocócica en adultos mayores. El nivel de conocimiento se relaciona con percepción en vacuna antineumocócica. En conocimiento de vacuna antineumocócica 47% tiene regular conocimiento en definiciones, 51 % regular conocimiento en importancia y 57% con regular conocimiento en normatividad. En percepción el 77% con mala percepción en seguridad sobre vacuna antineumocócica, 57% con percepción mala en afectividad familiar de vacuna antineumocócica y 63% con percepción buena en atención sobre vacuna antineumocócica.

Cruzado (17) en el 2023, con el objetivo “Analizar efectividad de vacuna antineumocócica en reducciones de morbilidad por COVID-19 en el adulto mayor en Ancash”. Estudio, observacional, analítico, retrospectivo. Muestra total de adultos de 60 años a más, con diagnóstico COVID-19 fallecidos y no fallecidos; con vacuna antineumocócica, notificados en sistemas HIS MINSA y NOTICOVID. Método, en los datos empleó tablas en Excel, para

estimar efectividad de vacunas antineumocócicas, se compara el evento de interés “muerte por COVID-19” entre dos cohortes. Resultados, hay relación de variables vacunación antineumocócica en reducción de morbi-mortalidad por COVID-19, valor $p=0.000$ menor a 0.05. Hay un adulto mayor no vacunado por tres vacunados. Hay efecto significativo de vacunación antineumocócica en baja morbimortalidad por COVID-19 en adultos mayores.

Vidal (18) en el 2022, con el objetivo “Determinar las percepciones de las vacunas con nivel de conocimientos, actitudes y prácticas hacia COVID-19 en adultos mayores de un hospital en Lima, Perú”. Estudio descriptivo, transversal. Muestra de 84 adultos. Metodo, adaptó y validó instrumentos que miden nivel de conocimientos, actitudes y prácticas, la percepción sobre vacunas fue con cuestionario exploratorio. Resultados, la mayoría conoce las causas y síntomas, 56% cree que se transmite por alimentos contaminados, el 67% usa medicina tradicional en prevención, y 64% dice es insuficiente el nivel de conciencia social, el 95% se vacunó por COVID-19, el 64% dice que las vacunas son seguras.

Acuña (19) en 2020, con el objetivo “Analizar factores que relacionan con incumplimiento de las vacunas de influenza y neumococo en adultos mayores en puente piedra 2020”. Estudio, descriptivo, cuantitativo, no experimental. Muestra de 40 adultos mayores. Método, como técnica fue las encuestas e instrumento las entrevistas. Resultados, la población adulta mayor de 60 a 65 años es 77%, el factor cultural la población adulta es 24% dicen que son saludables y no necesitan vacunarse. El 51% confía en medicina natural; el 31% su creencia no aprueba vacunas, lo institucional dice que 17% no recibe buen trato; los adultos mayores en 44% que no les explican de vacunas. El 40% dice que la infraestructura no es adecuada.

Benavides (20) en el 2023, con el objetivo “Analizar las experiencias de vacunación contra COVID-19 en adultos mayores de un centro de salud Chota”. Estudio, cualitativa, abordaje descriptivo. Muestra de 104 adultos mayores. Método, la recolección de datos utilizó

instrumento de entrevista semiestructurada. Resultados, surgen categorías: 1) Atención humanizada centrada en paciente en vacunación. 2) Reacción post vacunación COVID-19. 3) Experiencia de seguridad y protección en cumplimiento de dosis. Los adultos mayores dicen que su experiencia con vacunación de COVID – 19, fue positiva por sentimiento de seguridad, trato humanizado dado por personal de enfermería y ausencia de reaccion adversa de la vacuna contra COVID - 19.

2.2. Base Teórica

2.2.1. Primera variable: Nivel de conocimiento

Es "colección de hechos o información que una persona adquiere por la experiencia. Es una variedad de problemas, resultados exactos, hechos exactos, conocimiento que da precisión, descripción casi exacta, medición exacta; dice que el conocimiento va más allá de hechos reales, para crear nuevos hechos y explicarlos. El conocimiento es "la actividad de proceso práctico. El conocimiento no existe sólo por sí mismo, sino que ayuda a personas a cambiar sus vidas y resolver los problemas de la vida". El conocimiento es “hechos y argumentos que enfatizan aquellos hechos que impiden la herencia de procesos mentales en lugar de la herencia de procesos físicos. Cuando el conocimiento se adquiere en acción conociendo el material de acción de la mente, el conocimiento también se llama esencia y evidencia. Los conocimientos se adquieren, intercambiar, combinar y compartir entre sí. No son verdaderos objetivos porque pueden evaporarse del individuo en contacto con personas” (21).

Tipos de conocimiento

Conocimiento intuitivo: Conocimiento utilizado cada día en la vida cotidiana, que permite a las personas acceder rápidamente al mundo que les rodea, incluye conocimientos especializados, elegir a partir de la experiencia personal, es decir, tratar de relacionarlo con

hechos vividos, lo cual es Asimilación. **Conocimiento científico:** Se da por hipótesis contrastada y comprobada mediante estrategia cuidadosa, y las conclusiones son objetivas, determinadas por voluntad de cada persona en el proceso de brindar dicha información. La investigación se sustenta en el conocimiento científico a medida que se analiza y se buscan explicaciones fáciles de entender para reconocer y proceder a conclusiones (22).

Escala de medición del conocimiento

Para evaluar el conocimiento del programa de vacunación, se realizó una verificación de antecedentes entre los padres de adolescentes con bebés menores de 1 año que serían participantes del estudio. Para categorizar resultados de encuesta completa, los antecedentes son los siguientes: Conocido: significa que comprende el programa de vacunación y tiene entre 12 y 16 respuestas correctas. Poco Conocimiento: Si se sabe poco sobre el calendario de vacunación, pero la respuesta correcta tiene un valor de 6 - 11. Desconocido: Si se desconoce el calendario de vacunación, la respuesta correcta tiene menos de 5 valores (23).

Conocimientos cognitivos

Vacuna: Es preparado que contiene virus, microorganismos bacterianos vivos inactivados, que al administrarse en el cuerpo humano pueden producir inmunidad adquirida con diversas enfermedades. Vacunación: Se centra en proceso de fabricación, transporte, distribución, preparación, manipulación e inyección de vacunas, seguido de campañas dirigidas a padres y residentes para informar sobre la importancia de la vacunación. Inmunidad: Se refiere a capacidad del cuerpo en resistir y resistir ataques de virus y bacterias extraños (24).

Calendario de vacunación: ciclo temporal de administrar vacunas, conformando política nacional de prevención de enfermedades prevenibles por vacunación. Tarjetas de vacunación: Son individuales en grupos de edad, de preferencia a niños y mayores que

necesitan vacunarse. Almacenarlo y presentarlo en punto de control del centro de salud. Permitirá según registro de vacunación del MINSA. Conocimiento: “Hechos o información que la persona adquiere por experiencia. El conocimiento da precisión, descripciones, medida exacta el conocimiento excede hechos reales y crea nuevos hechos (25).

Cumplimiento: se refiere al comportamiento y resultados de realizar ciertas acciones confiables, es el cumplimiento de una obligación o elección. Inmunidad: Se refiere a la capacidad del cuerpo para resistir y defenderse contra la invasión de patógenos extraños. ESAVI: es cualquier evento adverso relacionado con las vacunas e inmunización (26).

Conocimiento de vacunas

Considere las conexiones conceptuales, la información con precisión requerida y secuencia adecuada de las vacunas parentales. Las madres también disponen de abundante información sobre las vacunas de sus hijos, incluidas las enfermedades prevenibles mediante vacunación y sus efectos secundarios. De manera similar, el conocimiento sobre vacunas se almacena a través de experiencias e información sobre vacunas y vacunaciones infantiles (27).

Dimensiones de nivel de conocimiento.

Primera dimensión: Generalidades de la vacunación:

Se define como procedimiento o conjunto de procedimientos para el aseguramiento nacional de inmunidad vacunal y su administración en establecimientos de salud públicos del país, donde el personal de enfermería es responsable de registrar y descifrar dosis de vacuna administradas. Las vacunas son productos biológicos de microorganismos muertos (inactivados), debilitados, que se utilizan para enfermedades infecciosas en poblaciones susceptibles. Las vacunas replican la enfermedad sin causar infección, estimulan la inmunidad para el desarrollo de mecanismos de defensa que se activan cuando el sistema se

expone a microorganismos que causan enfermedades. La vacunación protege de enfermedad común y graves, mortales o debilitantes. Muchas enfermedades para las que disponemos de vacunas han desaparecido o controladas gracias a vacunación en nuestro entorno (28).

Segunda dimensión: Prevención de enfermedades:

Es característica esencial de salud pública con cinco partes del proceso de integración, etapas en salud. Es posición, en grupo de personas a promover y proteger. Según la Administración de Drogas y Alimentos de EE. UU. (FDA), enfermedades infecciosas que eran comunes en polio, difteria, tosferina, rubéola y varicela, se previenen por FDA. Vacunas aprobadas. Previenen enfermedades infecciosas que han matado bebés, niños y adultos. FDA garantiza que las vacunas sean seguras y eficaces. Las personas, desde bebés hasta adolescentes, deben vacunarse para dar inmunidad contra enfermedades infecciosas potencialmente peligrosas. Sin vacunación, hay riesgo de sufrir enfermedades graves, discapacidad o muerte a causa de enfermedades como Haemophilus influenzae tipo b (Hib), sarampión y tos ferina (29).

Tercera dimensión: Efectos y cuidados en la vacunación:

Se consideran efectos que ocurren antes y después de vacunación, el papel del enfermero es compensar efectos de la vacuna desde el individuo por enseñanza dirigidas a través de lo pedagógica. Incluye métodos para determinar el estado de salud general antes de vacunación. El Departamento de Salud buscar formas de conectar los componentes de la institución, desarrollar métodos de comunicación y crear resumen de las personas en campo y demostrar e informar a padres en momentos adecuados de los pasos y dosis a seguir después del proceso de vacunación. Las vacunas pueden causar dolor o efectos secundarios que pueden provocar cambios en su cuerpo y sus sistemas. El ciclo de 48 horas, se observa protección y cuidado para molestias secundarias, los efectos son dañinos, innecesarios y no deseados (30).

2.2.2. Segunda variable: Cumplimiento del uso de la vacuna neumocócica en el calendario de vacunación

Cumplimiento del esquema de vacunación

Dependiendo de las circunstancias, la participación en la visita de vacunación gratuita de su hijo es opcional u obligatoria. También lo es cumplimiento materno de vacunas. En el mismo contexto, se mencionó que la vacunación es medida sanitaria que reduce la mortalidad juvenil y erradicar en América enfermedades de fama mundial como polio o la viruela. Esta medida se consideró rentable para promover la salud y riqueza de la gente (31).

Norma Técnica De Inmunización (NTS N° 080 - MINSA/DGSP V.03).

Contribuir a mejora de salud de población por prevención y control de enfermedad prevenible por vacunación. Objetivo. Establecer plan y calendario ordenado de vacunación obligatoria a nivel nacional en promover intervenciones según Estrategia Nacional de Inmunización en Salud (ESNI). Esta norma técnica en salud aplica a instituciones públicas, instituciones mixtas del sector privado e instituciones de salud a nivel nacional (32).

Importancia de la vacunación.

Una vacuna es un medicamento biológico que, cuando se administra a personas sanas, produce mecanismos de protección (anticuerpos) que protegen a las personas de infecciones o enfermedades protegiéndolas del agente infeccioso contra las vacunadas. Benefician a poblaciones susceptibles vacunadas como no vacunadas. La vacunación es estrategia de prevención eficaz para salud pública, hay mayor rentabilidad y reducción de morbilidad y mortalidad. Prevenir enfermedades por vacunación en países pobres. Demografía. Por eficacia de la vacunación, los departamentos de salud desarrollan planes de vacunación que constan de calendarios en lograr alta cobertura de vacunación y bajar enfermedades (33).

Dimensión nivel de cumplimiento

Es deseo de cumplir con vacunas incluidas en Plan Nacional de Vacunación del MINSA, que es conjunto de pautas de prevención de vacunación. El estado de salud del país es: Vacuna BCG: previene tuberculosis B: propagación de hepatitis B, previene difteria, tétanos, hepatitis B y Haemophilus influenzae tipo B. Inyección de polio: prevenir polio. Rotavirus: Previene diarrea severa. Primero. Streptococcus pneumoniae: previene otitis media, sepsis, meningitis y neumonía grave. Rotavirus. 2. Neumococo, tercer tratamiento pentavalente, tercer tratamiento contra polio. Gripe no. 1: Actualmente, el MINSA da esta vacuna gratuita a personas vulnerables, personas mayores de 60 años. Segunda temporada de gripe (34).

Calendario de vacunación

Es el único en todo el Perú que sigue el mismo método obligatorio en instituciones de salud públicas y privadas que realizan campañas de vacunación y que debe aplicar según grupos de edades distribuidos en la región. El programa de vacunación incluye inyecciones de los fármacos inmunobiológicos: Vacuna contra el bacilo de Calmette-Guérin (BCG). La vacuna contra la hepatitis B más de 2000 gramos en dosis de 0,5 ml por vía intramuscular en tercio medio del muslo en 12 horas, con jeringa de 1 cc y jeringa de 25 G x 5/8 aguja (35).

Vacuna pentavalente

Contiene células enteras inactivadas de Bordetella pertussis, toxoides diftérico y tetánico, anticuerpos del virus de hepatitis B y polisacáridos conjugados de Haemophilus influenzae. Vacuna con toxoide diftérico (DT) Vacuna para niños. Las vacunas están en viales de 10 dosis de 5 ml de suspensión blanquecina vía intramuscular. Vacuna contra Haemophilus influenzae tipo B (HIB) HIB es polisacárido capsular purificado que da inmunidad contra infecciones por HIB, agente causante de neumonía, meningitis y otitis media (36).

Vacuna contra la poliomielitis

Vacuna inactivada (IPV o SAIK), inyectable que consiste en poliovirus inactivados. La vacuna oral contra la polio (APO SABIN) es una suspensión oral en vial multidosis y consta de tres dosis. Vacuna contra rotavirus. Es vacuna para prevenir la diarrea de rotavirus y se administra por vía oral con intervalo de 2 meses entre la primera y segunda dosis. La vacuna neumocócica previene infecciones invasivas por *Streptococcus pneumoniae* y protege contra enfermedades respiratorias bacterianas (37).

Vacuna contra sarampión, paperas y rubeola (SPR)

SPR contiene virus vivo atenuado en viales liofilizados en ampollas que contienen 0,5 ml de disolvente para inyección subcutánea. **Vacuna contra sarampión y rubéola (SR).** La SR son virus vivo atenuado, que se inyecta subcutánea en 0,5 ml en zona del deltoides. **Vacuna contra la varicela.** La vacuna se prepara liofilizado de cepa viva atenuada de varicela y se administra en dosis única. La dosis es de 0,5 ml, inyectada vía subcutánea (deltoides). **Vacuna contra la fiebre amarilla.** Protege de infección que causa la fiebre amarilla (38).

Vacuna contra la difteria, pertussis y tétanos (DPT)

La DPT es combinación de vacunas muertas que protegen contra tosferina, tétanos y difteria. Se administra dosis en primer refuerzo, segundo refuerzo e inyección intramuscular en parte superior del brazo. **Vacuna DT para adultos.** Es vacuna inactivada que protege contra difteria y tétanos. **Vacuna combinada DTPA (mujeres embarazadas).** Es vacuna acelular de toxoides tetánico y diftéricos con componentes de tosferina, en prevención de tétanos, difteria y tosferina. **Vacuna contra virus del papiloma humano (VPH).** Es viral inactivada protege contra infecciones que causan cáncer de cuello uterino. Administrar dosis de 0,5 ml. Parte superior lateral del brazo que reciben en instituciones públicas y privadas (39).

Vacuna contra la Influenza

Contiene 3 cepas y se cambia cada año según las pautas y recomendaciones de OMS. Es importante vacunarse antes de invierno: La primera dosis se inyecta por vía intramuscular en cara anterolateral parte externa del muslo. Se administra una dosis, mujeres embarazadas luego de 20 semanas y posparto, segunda dosis a mayores de 60 años o más (40).

Vía y lugar anatómico de administración

Los medicamentos se administran de diferentes maneras, como ejemplo: Oral: las vacunas contra la polio y rotavirus se administran dependiendo del tipo y rendimiento de vacuna, si es una sola dosis como la vacuna contra el rotavirus o de múltiples dosis, ejemplo, cura para poliomielitis. Tipo de inyección: se usa para inyectar la vacuna. En inyección hay daños a vasos sanguíneos, tejidos y nervios en lugar de inyección. Las vacunas fraccionadas son por vía intramuscular, en músculo para la rápida absorción. Las vacunas administradas incluyen pentavalente, neumocócica, IPV, DPT, HIB, HVB y vacunas inactivadas en influenza (41).

Los sitios de vacunación son: A. Parte externa del muslo o músculo vasto lateral: este sitio es sitio de inyección intramuscular adecuado. El alcance es dividir el espacio entre trocánter mayor del fémur y la rodilla en tres partes, y trazar una línea semihorizontal imaginada por el personal sanitario para dividirlo en tres partes. Tercio medio. El lugar de punción se encuentra en el triángulo básico debajo del acromion y ápice, debajo del músculo deltoides. El área triangular es sitio de punción. Inyección subcutánea o vía subcutánea: La aplicación es en tejido adiposo y es una vacuna que se absorbe lentamente en segundos (42).

Para administrar estas vacunas, la aguja se inserta en pliegue que se forma pellizcando con dedos, teniendo en cuenta el ángulo de inserción de aguja, se insertará en ángulo de 45 grados donde: Jeringuilla desechable 1 cc con Aguja Retráctiles 25 G x 5/ 8" Ruta Intraaguja:

Penetrar dermis, la dosis es 0.01ml de biológico, será de absorción lenta. Cuando se inserta la aguja, el bisel debe quedar hacia arriba ángulo de 15 grados. La inyección es con cuidado; forman pápulas en lugar de inyección (43).

Reacciones posvacunación:

Local: dolor, eritema, edema e induración. Síntomas sistémicos: malestar, dolor de cabeza, fatiga. Cuidados luego de vacunación. Luego de vacunación, dar información de estrategias para ayudar a mitigar y controlar condiciones de salud que ocurre en situaciones posteriores a vacunación, ejemplo: aconsejar que descansen por completo y eviten actividades extenuantes. No masajear sitio de aplicación. Manejo de medios físicos. Contraindicaciones de vacuna. Ocurre reacciones si la vacuna se administra antes de administrarla (44).

Seguridad acerca de la vacuna antineumocócica en el adulto mayor.

Es el estado de control de peligros y condiciones que causa daños físicos, mental o material con fin de mantener la salud y bienestar del individuo y comunidad. Es fuente indispensable de vida diaria que permite a los individuos y sociedad realizarse. La seguridad humana como creación y mantenimiento de entorno que reduce los riesgos y la incertidumbre y promueva la conciencia de la dignidad humana. Las investigaciones muestran que es vacuna segura, ya que los efectos secundarios graves son raros. Las más frecuentes son reacciones locales leves (50%), como pápulas eritematosas, dolor local y mialgias. En menos del 1% se produce fiebre alta o síntomas pronunciados. Los fenómenos alérgicos se describen excepcional (45).

Esto se debe al hecho de que estos pacientes tienen altos niveles de anticuerpos en suero. Los valores de anticuerpos antes de vacunación se asocian con riesgo de efectos secundarios luego de primera dosis. La asociación entre eventos adversos relacionados con revacunación y valores de anticuerpos se relaciona con el tiempo en primera vacunación y revacunación.

No hay contraindicaciones para este tipo de vacunas, aunque se considera mejor no usar en el embarazo. Es posible no ser adecuados para vacunación en pacientes inmunodeprimidos, ya que pueden no ser eficaces, aunque la vacuna 2 semanas antes o 3 a 4 semanas luego del tratamiento es una alternativa para los pacientes que reciben terapia inmunosupresora (46).

Afectividad familiar acerca de la vacuna antineumocócica en los pacientes adultos mayores

Las emociones son capacidades que no tienen la misma dimensión en las personas. Estas capacidades de nuestro inconsciente experimentan emociones que van de motivaciones racionales. Las familias no juegan un papel importante en experiencias emocionales en la familia, también contribuyen al desarrollo social por relaciones se desarrollen con otras personas fuera de familia que es unidad social relacionada con personas mayores. Promueve el desarrollo de bienestar y seguridad, muchas personas mayores viven en soledad, abandono y con depresión, porque se sienten tristeza cuando están lejos de seres queridos. Las malas relaciones de familias y personas mayores llegan a tristeza, irritabilidad y melancolía, afecta su calidad de vida. Las relaciones familiares son esenciales en las personas mayores que necesitan conectarse con otros para vida mejor y compartir alegría. En vacunas, los familiares no vacunan al anciano porque en el tiempo tendrá efecto negativo en salud (47).

Atención acerca de la vacuna antineumocócica en los pacientes adultos mayores.

Las reformas realizadas para modernizar el sector sanitario trajeron cambios, se decidió usar el término "cliente" o "usuario" en lugar de "paciente". El servicio al cliente son actividades realizadas en clientes antes, durante y después de compra. Conocido como servicio al cliente, para garantizar la satisfacción con producto o servicio. Satisface necesidad del cliente externo mejor que sus competidores. La satisfacción está en evaluaciones posconsumo y postpaso, se modifica en transacción, fuente de desarrollo y cambio de actitud en objetos de

consumo y empleo, psicología social. El entorno que se vacuna a ancianos, los familiares que vacunan y apoyo de enfermería influyen en eficacia de vacuna administrada (48).

Teoría de Dorothea Orem

El modelo Orem examina exhaustivamente el autocuidado de las personas y la contribución humana a la mejora de la calidad de vida. Esta teoría consta de tres modelos teóricos interrelacionados: autocuidado, sistemas de cuidado y Déficit de autocuidado, demuestra que se plantea como teorías que los individuos tienen capacidad para cuidar de sí mismos (49).

Teoría del autocuidado

Define autocuidado como la inversión de un individuo en su existencia: "El autocuidado es una actividad aprendida y dirigida a objetivos, un comportamiento que existe en situaciones específicas de la vida y que las personas dirigen hacia sí mismas. El yo hacia los demás o la actitud hacia el medio ambiente". regular los factores que afectan el autodesarrollo y el funcionamiento de una persona por el bien de la vida, la salud o el bienestar" (50).

Teoría del déficit de autocuidado

Utilizando esta teoría, explica las posibles razones de este déficit, cuándo y por qué es necesaria la intervención de enfermería, y sostiene que las personas con limitaciones debido a la salud o su condición no pueden permitirse el lujo de depender del autocuidado (51).

Teoría de los sistemas de enfermería

Explicar cómo enfermería cuida a las personas utilizando dos tipos de sistemas: Sistema de enfermería parcialmente remunerado: (Cuidados dados por personal de enfermería). Educación sobre el sistema de atención de apoyo: los cuidadores actúan ayudando a las personas a realizar actividades de autocuidado que no podrían realizar sin la asistencia (52).

2.3. Formulaciones de hipótesis

2.3.1. Hipótesis general

Hi: Existen relaciones estadísticamente significativas de niveles de conocimientos con el cumplimiento del uso de la vacuna neumocócica en el Servicio de Inmunización del adulto mayor del Centro de Salud Breña Lima 2025

H0: No hay relaciones significativas del nivel de conocimiento con el cumplimiento del uso de la vacuna neumocócica en el Servicio de Inmunización del adulto mayor del Centro de Salud Breña Lima 2025

2.3.2. Hipótesis específicas

H1: Existe relación estadísticamente significativa del nivel de conocimiento en su dimensión definiciones de la vacuna antineumocócica con el cumplimiento del uso de la vacuna neumocócica en el Servicio de Inmunización del adulto mayor del Centro de Salud Breña Lima 2025.

H2: Existen relaciones estadísticamente significativas de niveles de conocimientos en dimensión esquema de Inmunizaciones de la vacuna antineumocócica en el adulto mayores con el cumplimiento del uso de la vacuna neumocócica en el Servicio de Inmunización del adulto mayor del Centro de Salud Breña Lima 2025.

H3: Existen relaciones estadísticamente significativas de niveles de conocimientos dimensión medidas ante las reacciones adversas de la vacuna Antineumocócica con el cumplimiento del uso de la vacuna neumocócica en el Servicio de Inmunización del adulto mayor del Centro de Salud Breña Lima 2025.

CAPITULO III. METODOLOGÍA

3.1.Métodos de investigación

Se utilizaron en este estudio hipotéticos-deductivos porque ya que nos permitió hacer las hipótesis que explican un hecho real para poder inferir la posible consecuencia. Son procesos que se inician en algo. Estas declaraciones son de naturaleza hipotética e intentan refutar o falsificar estos supuestos y derivar hechos de ellos (45).

3.2. Enfoques de investigación

Nuestro trabajo a investigar tiene el método cuantitativo a saber, calcular estadísticas descriptivas y estadísticas inferenciales utilizando el valor numérico relevante que analizan con precisiones el dato obtenido. Entre ellas, se recomienda la recopilación de datos basada en análisis estadísticos y mediciones numéricas para probar hipótesis y crear pruebas teóricas y modelos de comportamiento (46).

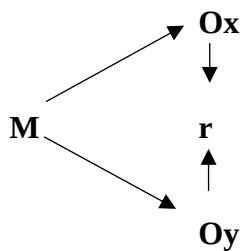
3.3. Tipos de investigación

Es aplicado con la medida de posible y práctico, recopilar información respaldada por norma y manual técnico, y proponer solución al problema que garantice intervención exitosa. Existiendo ciertos grados de correlaciones porque se intenta analizar los comportamientos de los dos, se intenta analizar las correlaciones en ellos cuando formulamos hipótesis. Según la secuencia de corte, se realizó un estudio transversal debido a que la información fue recolectada en un momento determinado del estudio (47).

3.4. Diseños de la investigación

Esta investigación tiene características no experimentales debido a que se observan los comportamientos de dichas variables donde no se analizan ni se modifican ellos. Este diseño

también es descriptivo con estudios observacionales; el estudio tiene un corte transversal. Es decir, estas informaciones se han tomado en momentos determinados. Sus propósitos son describir a las variables y analizar su ocurrencia y sus interrelaciones a lo largo del tiempo (48). El diseño es:



Dónde:

M = Muestra.

Ox = Nivel de conocimiento

Oy = Cumplimiento del uso de la vacuna neumocócica

R = Relación entre las variables

3.5. Población, muestra y muestreo

Una población es grupo de individuos de una misma categoría que está sujeto a las limitaciones de un estudio. Una población es el fenómeno en estudio, en la que las unidades de la población comparten características comunes que se estudian y obtienen datos de la investigación”. La población total de estudio fue de 180 adultos mayores. El estudio seleccionará sistemáticamente a 144 adultos mayores del Centro de Salud Breña.

Criterios de inclusión:

- Registros de personas igual o mayor de 60 años diagnosticado con COVID19, con PCR o pruebas rápidas.
- Personas igual o mayor de 60 años con administraciones de las vacunas antineumocócica durante el año 2021 hasta 2025

Criterios de exclusión:

- Personas mayores de 60 años que no acepte ser parte del estudio.
- Personas mayores de 60 años que no desean firmar el consentimiento informado
- Registros incompletos del dato de pacientes iguales o mayores de 60 años con diagnósticos del COVID-19 y vacunaciones antineumocócicas.

Muestra:

Las muestras se crearon usando probabilidades aleatorias simples, se han considerado que los individuos tenían la única posibilidad para poder ser seleccionados. En las determinaciones los tamaños de las muestras, utilizan las siguientes fórmulas según los tamaños de las muestras en la población finita:

$$n = \frac{z^2 p q N}{E^2 (n-1) + z^2 .p.q}$$

Es:

Poblaciones N = 180

Nivel de confianza Z2 se define como el margen de confiabilidad o las unidades de desviación estándar distribución normal que generarán un nivel de confianza deseado: 95%,
 $X=0.05$, $Z=1.96$

Proporciones al favor $p = 0.5$

Proporciones en contras $q = 0.5$

Tamaños de las muestras o errores muestrales $n = 0.03$

Se reemplazan:

$$n = \frac{1.96^2 \times 0.05 \times 0.5 \times 180}{0.05^2 \times (180 - 1) + 1.96^2 \times 0.5 \times 0.05}$$

$$n = \frac{328.4568}{2.27226}$$

$$n = 144.55071$$

Muestreos:

Estos trabajos tienen muestreos probabilísticos, por ello, se trabajaron en 144 personas mayores del Centro de Salud Breña.

3.6. Variables y operacionalización

Variables de estudio

V1: Nivel de conocimiento

V2: Cumplimiento del uso de la vacuna neumocócica

Matriz de consistencia

Variables	Definición conceptual	Definición operacional	Dimensiones	Indicadores	Escala de medición	Escala valorativa (Niveles y rangos)
V1: Nivel de conocimiento	Mismo las vacunas son consideradas como biológicos que son administradas a las personas sanas con el objetivo de producir una reacción inmune a ciertas enfermedades (49).	Son las preguntas que se aplicaron a los mayores del Centro de Salud Breña, mediante el instrumento de 13 preguntas distribuidas en tres dimensiones,	Definiciones de la vacuna antineumocócica	La vacuna es un preparado a base de virus o bacterias, que se introducen al cuerpo para que éste lo reconozca y desarrolle anticuerpos Prevenir la neumonía con la vacuna antineumocócica, significa evitar la enfermedad en forma severa Sobre la protección, la vacuna antineumocócica NO protege contra la neumonía por COVID 19	Nominal	Alto Medio Bajo
			Esquema de Inmunizaciones de la vacuna antineumocócica en el adulto mayores	¿Sabía usted que con una dosis única de la vacuna antineumocócica del Ministerio de Salud lo protege de por vida contra la neumonía severa? Puede aplicarse la vacuna antineumocócica y otra vacuna simultáneamente Sabía Ud. que para la vacunación antineumocócica debe acudir a al establecimiento sin fiebre u otro malestar porque pueden atribuir a la vacuna los síntomas de alguna otra enfermedad.		
			Medidas ante las reacciones adversas de la vacuna Antineumocócica	Ante los cuidados básicos al presenta fiebre y/o dolor, tras la administración de la vacuna antineumocócica se puede tomar una tableta de paracetamol 500 mg y no frotar la zona de aplicación. ¿Si presenta fiebre después de la vacunación antineumocócica debe acudir al hospital?		
V2: Cumplimiento del uso de la vacuna neumocócica	La decisión de no vacunar, trae consigo muchas complicaciones a la salud de la infancia, se corre el riesgo de que emerjan enfermedades ya controladas a través de los tiempos gracias a la vacunación (50).	Son las observaciones sobre el cumplimiento del uso de vacunas neumococicas mediante lista de cotejo si cumple o no cumple	VACUNA ANTINEUMOCOCICA	Desconocimiento del esquema Me puse mal o me dio reacción Porque mi religión me lo prohíbe Experiencia negativa de algún familiar o persona conocida Porque no confío en las vacunas de los establecimientos de salud	Nominal	Cumple No cumple

3.7. Técnica e instrumento de recolección de datos

3.7.1. Técnicas

El trabajo usó las técnicas de las encuestas, que son técnicas en recabar información mediante preguntas a los sujetos que se creen que tienen informaciones que se necesitan. La investigación da la información a mayores escalas que de otros métodos (observaciones directas, experimentos). La encuesta genera y recopila fielmente las informaciones sobre características, actitudes, opiniones y motivaciones socioeconómicas.

3.7.2. Descripciones del instrumento

Instrumentos de los niveles de conocimientos.

Las técnicas utilizadas para esta investigación son las encuestas, que ayudan para obtener informaciones precisas y efectivas. En las determinaciones de los niveles de conocimientos, se utilizó una herramienta de recolección de datos cuestionario desarrollado por los autores Victoria Gamarra Cuenca y Abel Silva Sandoval, modificado por el tesista Jimmy Jorge Torres Bellido en 2025 y validados con 3 expertos para determinar el nivel de conocimientos. Esta prueba de conocimientos incluyó 13 preguntas (51).

Instrumento del Cumplimiento del uso de la vacuna neumocócica

La lista de control de cumplimiento del calendario de vacunación fue elaborada por el mismo autor y con base en el calendario de vacunación se registró con una chequin el lugar donde fue vacunado y se le asignó un código según su edad. El acta final es: Sí, se cumplen los requisitos. Cuando los pacientes reciben todas las vacunas según la edad. Fallido (no cumple). Si se ha saltado una vacuna debido a su edad.

3.7.3. Validación

La validez es “el grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 12). Es así, la validez de contenido, que es “la medida en que un instrumento refleja un dominio de medición específico” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 12), fue seleccionada por tres expertos para la evaluación inicial. Es válido y cumple con la significancia estadística de 0,88 entre la primera y la segunda variable estimaciones de 0,89.

3.7.4. Confiabilidad

Se inició con una prueba alfa de Cronbach para determinar la confiabilidad según lo requieren las escalas de medición tipo Likert. Se espera encontrar respuestas con coeficientes superiores a 0,8, lo que indica una alta confiabilidad dados los ítems estandarizados de la evaluación administrada. Según los autores Gamarra Cuenca Victoria y Silva Sandoval Abel, “La especificidad de la medición se refiere a la ausencia de error de medición o al grado de consistencia y estabilidad de los valores obtenidos en múltiples mediciones del mismo instrumento”.

Confiabilidad del nivel de conocimiento

Estadísticas de fiabilidad Alfa de Cronbach es 0.91 y con 12 número de elementos.

Confiabilidad del cumplimiento del uso de la vacuna neumocócica

Estadísticas de fiabilidad Alfa de Cronbach es 0.87 y con 10 número de elementos.

3.8. Plan de procesamiento y análisis de datos

Inicio las colectas de la información, haciendo gestión referida a la autoridad donde se pueda poder tenerlas informaciones de Centro de Salud Breña. Se inició la recolección de datos,

llevando a cabo las correspondientes acciones con las autoridades pertinentes para obtener acceso a informaciones de Centro de Salud Breña. Inicialmente, se gestionó una carta para presentar a la Universidad Norbert Wiener según sugerencia del asesor. Esta correspondencia fue presentada al departamento de gestión del Centro de Salud, situado en el tercer nivel. Dos días después, el director del Centro de Salud aprobó el trabajo de investigación. Se destaca que este estudio reviste una importancia significativa, dado que la población no cumple con la vacunación oportuna de sus familiares, lo que representa un problema significativo en Breña, es útil en la población. Además, se estableció una coordinación con la responsable del departamento de inmunizaciones, quien facilitó la recopilación de datos de pacientes que carecen de actualización en el programa de inmunización, lo que permitió realizar el seguimiento pertinente.

La recolección de datos se realizó en marzo de este año a través de encuestas y visitas domiciliarias a cada individuo que cumplió con los criterios de inclusión, elaboración de carteles, pancartas y rotafolios para explicar la inmunización y promover la concientización. Una vez completado el trabajo de campo, cada estudio realizado fue verificado y codificado en consecuencia. Se ingresó los datos recopilados en la base de datos del programa Excel, luego desarrolle el software estadístico SPSS 20 y transfiera el Excel previamente preparado.

3.9. Aspectos éticos

Se realizó la investigación de forma ética y se analizaron los resultados el cual nos informara de las futuras investigaciones.

Principio de autonomía

De manera global, se respetaron las autonomías, es decir, todas las capacidades de los individuos para decidir. El consentimiento informado fue la mayor expresión de todo el

principio ya que es derecho universal. A cada uno de los entrevistados se les ha explicado todo el principio básico del trabajo de investigación que se está realizando y se les dieron el consentimiento informado y se han respetado su libre voluntad para que decidan en participar libremente.

Principio de beneficencia

Estos principios fueron aplicados según normas de enfermería donde se les explican a los pacientes los beneficios del trabajo de investigación que se está realizando. Para proteger la salud del participante, no fueron dañados su integridad física ni psicológica.

Principio de no maleficencia

Todo el principio ha sido referido en no causar daño alguno a los entrevistados, donde se les explico que este trabajo de investigación no puede causarles ningún daño, ni sufrimientos o discapacidades para su salud.

Principio de justicia

Este principio de justicia tiene un significado justo para todos los participantes del estudio ya que fueron tratados igualitariamente sin nada de discriminación, ni maltrato a todo el derecho.

4. Aspecto Administrativo

4.1. Cronogramas de actividades

ACTIVIDAD	AÑO: 2024																			
	Junio				Julio				Agosto				Setiembre				Octubre			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Se identifican al problema.	■	■	■																	
Se hacen las búsquedas bibliográficas a investigar.		■	■	■																
Se tienen a las problemáticas, marcos teóricos y de antecedentes.				■	■	■	■	■												
Se tienen importancias y justificaciones del estudio.					■	■	■	■												
Mostramos las poblaciones, la muestra y el muestreo.						■	■	■												
Se hacen las técnica y los instrumentos de toma de datos.							■	■	■											
Elaboración del aspecto bioético.								■	■	■										
Elaborar los método de análisis para los datos									■	■	■	■								
Se tiene el aspecto administrativo de la investigación.												■	■							
Se muestra a los anexo.												■	■	■						
Se aprueba el estudio															■	■				
Se sustentan este tesis																	■	■	■	■

4.2. Presupuestos

Rubros	Detalles	Montos (Soles)	Totales (Soles)
Recurso humano	Especialista estadísticos	1000,00	1000,00
Bien	Laptops	3000,00	3000,00
Servicio	Luz x 3 meses	500,00	500,00
	Internet x 3 meses	400,00	400,00
Totales, S/.			4900,00

REFERENCIAS

1. Organización Mundial de la Salud. Problemas y respuestas acerca de la enfermedad por coronavirus. Perú: OMS. 2020. Disponible en: <https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19>
2. Centro de Control y Prevención de Enfermedades. Covid-19. Perú: MINSA. Junio 2020. Disponible en: <https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html>
3. Organización Panamericana de la Salud. Enfermedad por COVID-19. Centro de enlace de alertas y emergencias sanitarias. Perú: MINSA. 2020. Disponible en: <https://www.paho.org/es/tag/enfermedad-por-coronavirus-covid-19>

4. Centro Nacional de Epidemiología, prevención y control de enfermedades. Boletín epidemiológico. Perú: MINSA. 2021 Volumen 30 - SE 04. Disponible en: https://www.dge.gob.pe/epipublic/uploads/boletin/boletin_20214.pdf
5. Ministerio de Salud. Decreto de urgencias que instituye variadas medidas excepcionales y temporales con el fin de prever la Para Prevenir La Trasmisión del Covid-19 dentro del país. Perú: MINSA. 2020. Disponible en: <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/566447/DU026-20201864948-1.pdf>
6. Gerencia Regional de Salud, La Libertad. Directiva que plasma el manejo de cadáveres por Covid-19. Perú: MINSA. 2020 Disponible en: http://www.digesa.minsa.gob.pe/Orientacion/directiva_sanitaria_087-2020-DIGESA-MINSA_para_el_manejo_de_cadaveres_por_covid_19_consolidado_actualizado.pdf
7. Ministerio de Salud. Norma Técnica de Salud, que establece el Esquema Nacional de inmunizaciones. Perú: MINSA. 2019. Disponible en: https://Resolucion_Ministerial_719-2018-MINSA1.pdf.
8. Ministerio de Salud. Vacunación por etapas de vida en el Perú. Perú: MINSA. 2019. Disponible en: <https://www.gob.pe/22037-esquema-regular-devacunacion-por-etapas-de-vida-en-el-peru>
9. Ministerio de Salud. Directiva de salud que norma disposiciones y medidas para operativizar la inmunización en el Perú en momentos del COVID-19, que forma parte integrante de la presente Resolución Ministerial. Perú: Minsa. 2020. Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/minsa/normaslegales/483087-214-2020-minsa>

10. Lewnard J. La prevención de la enfermedad por coronavirus 2019 entre adultos mayores que reciben la vacuna antineumocócica conjugada. *The Journal of Infectious Diseases*. Mayo de 2022. Volumen 225, número 10, páginas 1710–1720. Disponible en: <https://doi.org/10.1093/infdis/jiab128>.
11. Ekin T., Kış M., Güngören F., Akhan O., Atıcı A., Kunak A., Mutlu D., Katkat F., Demir M., Saraç İ., Soydan E., Karabulut D., Karaduman M., Alp Ç., Bekar L., Büyük F., Adıyaman M., Kaplan M., Zengin İ., Çalışkan S., Kıvrak T., Öz A., Eren H., Bayrak M., Karabulut U., Öztaş S., Düz R., Uluuysal Ö., Balun A., Sağır G., Kudat H., Pamukçu H., Abacıoğlu Ö., Göldağ Ö., Özmen Ç., Günay Ş., Zoghi M., Ergene A. Awareness and Knowledge of Pneumococcal Vaccination in Cardiology Outpatient Clinics and the Impact of Physicians' Recommendations on Vaccination Rates. *Vaccines (Basel)*. 2023 Mar 31;11(4):772. doi: 10.3390/vaccines11040772. PMID: 37112684; PMCID: PMC10142867. En internet <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10142867/> accedido el 20 de junio del 2024
12. Yilmaz F., Cakir M., Ikiisik H., Maral I. The Effect of Pneumococcal, Influenza, and COVID-19 Vaccinations on COVID-19 Hospitalization and Progression in People over 65 Years Old Living in Nursing Homes. *Vaccines (Basel)*. 2023 May 4;11(5):943. doi: 10.3390/vaccines11050943. PMID: 37243046; PMCID: PMC10222139. En internet <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10222139/> accedido el 20 de junio del 2024
13. Suitner C., Salvador C., Bruno G., Maggi S., Baldo V. An Independent Study to Compare Compliance, Attitudes, Knowledge, and Sources of Knowledge about

Pneumococcal Vaccinations among an Italian Sample of Older Adults. Vaccines. 10. 10.3390/vaccines10040490. 2022. En internet

https://www.researchgate.net/publication/359425931_An_Independent_Study_to_Compare_Compliance_Attitudes_Knowledge_and_Sources_of_Knowledge_about_Pneumococcal_Vaccinations_among_an_Italian_Sample_of_Older_Adults

accedido el 20 de junio del 2024

14. Fuller R., Huseh-Zosel A., Van Vleet B. Carson P. Barreras a la vacunación entre los adultos mayores: variación demográfica y vínculos con la aceptación de la vacuna. 2024. En internet

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2667032123000604> accedido el 20 de junio del 2024

15. Kobayashi M., Pilishvili T., Farrar J. Vacuna antineumocócica para adultos ≥ 19 años: recomendaciones del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización, Estados Unidos, 2023. MMWR Recomm Rep 2023;72(No. RR-3):1–39. DOI: <http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.rr7203a1>

16. Canchari I. Nivel de conocimientos y percepción sobre la vacuna antineumocócica en pacientes adultos mayores, Hospital de Ventanilla, 2021. En internet <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2667032123000604> accedido el 20 de junio del 2024

17. Cruzado A. Efecto de la vacunación antineumocócica en la reducción de la morbimortalidad por Covid-19 en adultos mayores en la región Ancash 2021”. En internet

https://repositorio.upao.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12759/10304/REP_ALEX_ANDRA.CRUZADO_VACUNACION.ANTINEUMOCOCICA_DATOS.pdf;jsess

[ionid=3080958E0892717B6B76E0AA4C2FFE46?sequence=1](#) accedido el 20 de junio del 2024

18. Vidal C., Percepción sobre las vacunas y nivel de conocimientos, actitudes y prácticas hacia la COVID-19 en adultos mayores de Lima, Perú. Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública [online]. 2022, v. 39, n. 2 [Accedido 15 Julio 2024], pp. 201-207. Disponible en: <<https://doi.org/10.17843/rpmesp.2022.392.10847>>. Epub 02 Set 2022. ISSN 1726-4642. <https://doi.org/10.17843/rpmesp.2022.392.10847>.
19. Acuña P. Factores relacionados al incumplimiento de las vacunas de la influenza y el neumococo en adultos mayores de 60 a 80 años de la Asociación de Vivienda Los Portales de Chillón, Puente Piedra-2020. En internet https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/77324/Acu%C3%B1a_CPJ-SD.pdf?sequence=1&isAllowed=y accedido el 20 de junio del 2024
20. Benavides M. Experiencias frente a la vacunación contra la COVID-19 de los adultos mayores en un centro de salud de Chota, 2023. En internet https://tesis.usat.edu.pe/bitstream/20.500.12423/6149/1/%C2%B4TL_BenavidesDiazMerly.pdf accedido el 20 de junio del 2024
21. Capillo A., Cabrera Y. Efectividad de la vacuna antineumocócica en la prevención de infecciones neumocócicas en población adulto mayor. Universidad Privada NORBERT WIENER Lima 2019. Diponible en <http://repositorio.uwiener.edu.pe/bitstream/handle/123456789/2957/TRABAJO%20ACAD%c3%89MICO%20Aza%c3%b1a%20Joselyn%20-%20Caruajulca%20Yudy.pdf?sequence=3&isAllowed=y>

22. Ministerio de Salud. Resolución Ministerial N° 780-2015/MINSA.,2020 Disponible en: file:///C:/Users/EPI-LPT-2/Downloads/Guia%20de%20registro%20HIS_2020.pdf
23. Ministerio de Salud, M. Cobertura de Inmunizaciones, from 2018. Disponible en: <http://www.minsa.gob.pe/estadisticas/estadisticas/indicadoresNac/inmunizacion.asp>
24. Organización Mundial de la Salud. Cobertura vacunal, from 2020. Disponible en: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/immunizationcoverage>
25. Organización Panamericana de la Salud. Enfermedad por el Coronavirus (COVID-19). Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, 2020. Disponible en: <https://www.paho.org/es/tag/enfermedad-por-coronavirus-covid19>
26. Organización Mundial de la Salud, O. Preguntas y respuestas sobre la enfermedad por coronavirus (COVID-19), 2020. Disponible en: <https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/>
27. Mandeep R. Cardiovascular Disease, Drug Therapy, and Mortality in Covid19, N. England, 2020. Disponible en: <https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2007621>
28. Gong L. Interés público en la distribución y los determinantes de la vacunación contra la influenza y la neumonía durante la pandemia de COVID19: una infodemiología y un estudio transversal de China. 2021. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34835258/>

29. Aldaz P. Mejorando las coberturas vacunales del adulto. El servir. Vol.28 Issue 6, suplement 1, junio-julio. 2021.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1134207221001420>
30. Anguis M., Surichaqui N., Ramos E. Conocimiento sobre inmunizaciones y el cumplimiento del calendario de vacunación en madres con niños menores de un año en el Centro de Salud de San Cristóbal. Huancavelica. (Tesis licenciatura) Universidad Nacional de Huancavelica. en:
http://repositorio.unh.edu.pe/bitstream/handle/UNH/1100/TP%20-%20UNH.%20ENF.%200082.pdf?sequence=1&isAllowed=y&fbclid=IwAR3NuW6etedMqLBrEBW_iHGNjBYkO1UOkYWPYKoLaTPeE6Ham8EB--3m_g
31. Antoñanzas L., Varona J., Antoñanzas F., Rejas J. La vacunación antineumocócica con la vacuna conjugada 13-valente en población inmunocompetente de 65 años: análisis del impacto presupuestario en España aplicando un modelo de transmisión dinámica. Revista Española de Salud Pública. 2020. 90(13): p.1-12.
www.redalyc.org/articulo.oa?id=17043728001.
32. Aristizábal H., Blanco B., Sánchez R., Ostigüín R. El modelo de promoción de la salud de Nola Pender: Una reflexión en torno a su comprensión. Enfermería universitaria, 8(4), 2021. 16-23. Recuperado en 11 de agosto de 2021, de
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-70632011000400003&lng=es&tlng=es.
33. Asociación Española de Pediatría. Vacuna neumococo. Portal virtual.
<https://vacunasaep.org/familias/vacunas-una-a-una/vacuna-neumococo>

34. Azaña J., Caruajulca Y. Efectividad de la vacuna antineumocócica en la prevención de infecciones neumocócicas en población adulto mayor. Título de especialidad en salud familiar y comunitaria. Facultad de Medicina. Universidad Wiener. Lima-Perú:
<http://repositorio.uwiener.edu.pe/bitstream/handle/123456789/2957/TRABAJO%20ACAD%C3%89MICO%20Aza%C3%B1a%20Joselyn%20-%20Caruajulca%20Yudy.pdf?sequence>
35. Boletín epidemiológico del Perú, VOLUMEN 29 - SE 39-2020 Semana Epidemiológica (del 20 al 26 de setiembre del 2020). Ministerio de salud, centro Nacional de epidemiología y control de enfermedades.
https://www.dge.gob.pe/epipublic/uploads/boletin/boletin_202039.pdf
36. Brote por enfermedad de coronavirus (COVID – 19). Organización mundial de la salud. 2019. https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus2019?gclid=Cj0KCQiA5bz-BRD-ARIsABjT4njMrMMZEoPuRQ1HcUuMX_UC6y8IrX4_e_OWz0zpVB0713ab8xttCcaAkq4EALw_wcB
37. Fernández J. Mortalidad por influenza y neumonía en el adulto mayor. Impacto de la vacunación anti influenza en este grupo poblacional. Matanzas 2001-2008. Rev. Med. Electrón. v.32 n.6 Matanzas nov.
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1684-18242010000600005
38. Flores M., Reolid R., López M., Alcantud P., Mudarra E., Azorín M., Escobar F. Riesgo de enfermedad neumocócica en pacientes ancianos con y sin vacunación previa. 2019. Atención Primaria, 51(9), 571-578
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0212656718302348>

39. Gallardo A. Evolución del conocimiento de enfermería. Revista Biomédica online MEDWAVE. 2018. Chile.
<http://mednet.cl/link.cg/MEDWAVE/Perspectivas/Opinion/5001>
40. Manual de vacunas en línea de la AEP. Comité asesor de vacunas. 2020.
<https://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-31>
41. Maxi A., Narváez J., Narváez M. Factores que influyen en el nivel de conocimientos de las madres adolescentes sobre el esquema del Programa Ampliado de Inmunizaciones del centro de salud n° 1 Azogues. Ecuador. 2021. (Tesis licenciatura) Universidad Nacional de Cuenca.
<http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/21238/1/Tesis%20Pregrado.pdf>
42. Ministerio de Salud Norma Técnica de Salud NTS N0 141-MINSA/2018/DGISP. Gob.pe https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/300034/d177030_opt.PDF
43. Minsa. El Boletín epidemiológico del Perú VOLUMEN 29-SE 02. Ministerio de Salud. 2020. <https://www.dge.gob.pe/portal/docs/vigilancia/boletines/2020/04.pdf>
44. Moraga A., Fernández M., Grande A., Martínez L., Moreno D., Pérez J. Recovering lost vaccine coverage due to COVID-19 pandemic. 2020. Vacunas.
<https://europepmc.org/article/med/32837461>
45. Hernández R., Mendoza C. Metodología de la Investigación: Ruta cuantitativa, cualitativa y mixta (1era edición). In. México: Mc Graw Hill; 2018. 148 – 151 pp.
46. Hernandez R., Fernandez C., Baptista P. Metodología de la investigación (6ta edición ed.). In. Mexico: Mc Graw Hill; 2016. 122 - 124 pp.

47. Ñaupas H., Mejía E. Novoa E. y Villagómez A. Metodología de la investigación científica y la elaboración de tesis. 3era edición. Perú. 2013 [citado el 02 de febrero 2021]
48. Hernández R., Fernández C., Baptista P. Metodología de la investigación [Internet]. 3° Edición. México: Mc Graw Hill; 2010 [citado el 20 de enero de 2021]. 656 p. Disponible en: https://www.esup.edu.pe/descargas/dep_investigacion/Metodologia%20de%20la%20investigaci%C3%B3n%205ta%20Edici%C3%B3n.pdf
49. Contreras M., Mora G., Orozco G., Hernández S., Estela M., Mozo M. Influencia del Conocimiento en las Actitudes en Madres con Niños Menores de 5 años ante el Esquema de Vacunación. Revista mexicana de medicina forense y ciencias de la salud [Internet]. 2021 [citado el 18 de febrero del 2024];7(1). Disponible en: <https://revmedforense.uv.mx/index.php/RevINMEFO/article/view/2944>
50. Soriano A. Conocimiento de las primigestas sobre el cumplimiento del esquema de vacunación, comuna Buena Fuente, 2021. La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2021. [citado el 11 de enero del 2024] Disponible en: <https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/6573>
51. Gamarra V., Silva A. Relación entre el nivel de conocimiento de las madres sobre inmunizaciones y el cumplimiento del esquema de vacunación de niños menores de cinco años de edad en el centro de salud Magdalena, noviembre, 2010 [Internet]. [citado 2 de junio del 2024]. Disponible en: http://Repositorio.Uwiener.Edu.Pe/Bitstream/Handle/123456789/43/026EapEnfermeríaGamarra_Cuenca%26SilvaSandoval.Pdf?Sequence=1&isallowed=y

Anexos

Anexo 1: CUESTIONARIO

Buenos días, le saluda Jimmy Jorge Torres Bellido tesista de la Universidad Norbert Wiener me encuentro realizando un trabajo de investigación sobre **Nivel de conocimiento y su relación con el cumplimiento del uso de la vacuna neumocócica en el servicio de inmunización del adulto mayor del Centro de Salud Breña Lima 2025**, para la obtención del título de licenciada en enfermería de tener los resultados me permitirá conocer la problemática y mejorar estrategia futuras para el bien del adulto mayor relacionado a la vacunación.

Los datos que Usted me brinda serán confidenciales y anónimos, le ruego me conteste con la veracidad.

Instrucción: Marque con un aspa (X) la respuesta que cree verdadera.

I. Datos del encuestado

1.1. Datos Generales

1. Edad del adulto mayor:

A. 60-64 () B. 65-69 () C. 70-74 () D. 75-79 () E. de 80 a más ()

2. Tiene algún tipo de seguro:

A SIS () B ESSALUD () C. OTROS () D. NINGUNO ()

3. Cuenta con Vacunación antineumocócica:

A. SI () B-NO ()

4. Presenta alguna enfermedad crónica y/o padeció de covid -19

A. SI () B-NO () C. covid 19 () Detalle

1.2. Datos Específicos

5. Procedencia

A- Costa () B. Sierra () C-Selva ()

6. Estado Civil:

A- Soltero (a) () B. casado (a) () C. Conviviente () D. Viudo (a) () E. Divorciado(a)
()

7. Grado de Instrucción:

A. Superior () B. Secundaria () C- Primaria () D-. No sabe leer. Ni escribir ()

8. Ocupación

A. Ama de casa () B. Independiente () C. Dependiente () D. No trabaja ()

II. Conocimiento sobre la vacuna antineumocócica.

Definiciones de la vacuna antineumocócica

1. ¿La vacuna es un preparado a base de virus o bacterias, que se introducen al cuerpo para que éste lo reconozca y desarrolle anticuerpos?

a. Si () b. No () c. Talvez ()

2. ¿Prevenir la neumonía con la vacuna antineumocócica, significa evitar la enfermedad en forma severa?

a. Si () b. No () c. Talvez ()

3. Sobre la protección, la vacuna antineumocócica NO protege contra la neumonía por COVID 19

a. Si () b. No () c. Talvez ()

4. ¿En el esquema de vacunación nacional, la vacuna antineumocócica es gratuita para el adulto mayor de 60 años?

a. Si () b. No () c. Talvez ()

Esquema de Inmunizaciones de la vacuna antineumocócica en el adulto mayor

5. ¿Sabía usted que con una dosis única de la vacuna antineumocócica del Ministerio de Salud lo protege de por vida contra la neumonía severa?

a. Si () b. No () c. Talvez ()

6.- Puede aplicarse la vacuna antineumocócica y otra vacuna simultáneamente?

a. Si () b. No () c. Talvez ()

7.- Sabía Ud. que para la vacunación antineumocócica debe acudir a al establecimiento sin fiebre u otro malestar porque pueden atribuir a la vacuna los síntomas de alguna otra enfermedad.

a. Si () b. No () c. Talvez ()

8. ¿Los posibles efectos secundarios relacionados a la vacuna antineumocócica son fiebre y dolor en la zona de aplicación?

a. Si () b. No () c. Talvez ()

Medidas ante las reacciones adversas de la vacuna Antineumocócica

9. ¿Si presenta fiebre después de la vacunación antineumocócica debe acudir al hospital?

a. Si () b. No () c. Talvez ()

10. Ante los cuidados básicos al presenta fiebre y/o dolor, tras la administración de la vacuna antineumocócica se puede tomar una tableta de paracetamol 500 mg y no frotar la zona de aplicación.

a. Si () b. No () c. Talvez ()

11. ¿Percibe algún temor o miedo a la reacción de la vacuna antineumocócica?

a. Si () b. No () c. Talvez ()

12. ¿Percibe el apoyo y acompañamiento familiar a la aplicación de la vacuna antineumocócica y sus cuidados?

a. Si () b. No () c. Talvez ()

13. ¿En general percibe Ud. como buena la atención del personal de salud a la vacunación?

a. Si () b. No () c. Talvez ()

LISTA COTEJO CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO DE VACUNACIÓN

VACUNA ANTINEUMOCÓCICA	CUMPLE	NO CUMPLE
Desconocimiento del esquema		
Me puse mal o me dio reacción		
Porque mi religión me lo prohíbe		
Experiencia negativa de algún familiar o persona conocida		
Porque no confío en las vacunas de los establecimientos de salud		
Porque no confío en el personal de los establecimientos de salud		
Porque se me olvidó		
Porque no tengo tiempo		
Porque no son necesarias o no creo en las vacunas		
Alguna contraindicación		
Falta de biológico		

¡GRACIAS POR SU PARTICIPACION!

Anexo 2: Consentimiento Informado

Estimado usuario, le invitamos a participar de este estudio, la misma que se encuentra del campo de la salud. Para validar su participación, antes debe conocer y comprender cada de los indicadores que se mencionan a continuación:

Título del proyecto: Nivel de conocimiento y su relación con el cumplimiento del uso de la vacuna neumocócica en el Servicio de Inmunización del adulto mayor del Centro de Salud Breña Lima 2025

Nombre de la investigadora: TORRES Jimmy.

Propósito del estudio: “Analizar la relación del nivel de conocimiento y su relación con el cumplimiento del uso de la vacuna neumocócica en el servicio de Inmunización del adulto mayor del Centro de Salud Breña Lima 2025”

Beneficio por participar: “Tendrá la posibilidad de conocer los resultados obtenidos, para que así se generen estrategias de atención al usuario dentro la actividad que realiza el profesional”

Riesgo del participante: “Tendrá la posibilidad de retirarse si cree que no está haciendo lo correcto al momento de la entrevista.

Beneficio de los participantes: “Todo participante se beneficiará con los resultados obtenidos del estudio, el cual se le deberá hacer llegar mediante vía telefónica o por medio de whatsapp.

Confidencialidad del participante: “Tendrá el derecho de mantener en reserva su participación, el cual se le comunicará en el momento de la entrevista

Inconvenientes y riesgos: “Ninguno, solo se le pide responder al cuestionario.”

Costos por participar: “No se realizará pago alguno por su participación.

Renuncia: “Usted puede dejar de formar parte del estudio cuando lo crea conveniente, sin ninguna sanción o perder el derecho de conocer los resultados del estudio.”

Participación voluntaria: “La participación en la investigación es totalmente bajo su voluntad, asimismo podrá retirarse cuando lo desee.”

DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO

Declaro haber sido informado del nombre, “los objetivos y de la información que alcanzare en el estudio la misma que será utilizada para fines exclusivamente de la investigación, lo que me asegura la absoluta confiabilidad del mismo, por lo que acepto participar en el estudio.”

“Nombres y apellidos del participante”	“Firma o huella”
“Documentos de identidad”	

“Doy fe y conformidad de haber recibo una copia del documento”

Anexo 3: Matriz de consistencia

FORMULACION DEL PROBLEMA	OBJETIVOS	IPÓTESIS	VARIABLE Y DIMENSIONES	DISEÑO METODOLÓGICO
PROBLEMA GENERAL: ¿Cuál es la relación del nivel de conocimiento con el cumplimiento del uso de la vacuna neumocócica en el Servicio de Inmunización del adulto mayor del Centro de Salud Breña Lima 2025? PROBLEMAS ESPECÍFICOS: •¿Cuál es la relación del nivel de conocimiento en su dimensión definiciones de la vacuna antineumocócica con el cumplimiento del uso de la vacuna neumocócica en el Servicio de Inmunización del adulto mayor del Centro de Salud Breña Lima 2025? •¿Cuál es la relación del nivel de conocimiento en su dimensión esquema de Inmunizaciones de la vacuna antineumocócica en el adulto mayores con el cumplimiento del uso de la vacuna neumocócica en el Servicio de Inmunización del adulto mayor del Centro de Salud Breña Lima 2025? •¿Cuál es la relación del nivel de conocimiento en su dimensión medidas ante las reacciones adversas de la vacuna Antineumocócica con el cumplimiento del uso de la vacuna neumocócica en el Servicio de Inmunización del adulto mayor del Centro de Salud Breña Lima 2025?	OBJETIVO GENERAL Analizar la relación del nivel de conocimiento con el cumplimiento del uso de la vacuna neumocócica en el Servicio de Inmunización del adulto mayor del Centro de Salud Breña Lima 2025 OBJETIVOS ESPECÍFICOS •Determinar la relación del nivel de conocimiento en su dimensión definiciones de la vacuna antineumocócica con el cumplimiento del uso de la vacuna neumocócica en el Servicio de Inmunización del adulto mayor del Centro de Salud Breña Lima 2025 •Determinar la relación del nivel de conocimiento en su dimensión esquema de Inmunizaciones de la vacuna antineumocócica en el adulto mayores con el cumplimiento del uso de la vacuna neumocócica en el Servicio de Inmunización del adulto mayor del Centro de Salud Breña Lima 2025 •Determinar la relación del nivel de conocimiento en su dimensión medidas ante las reacciones adversas de la vacuna Antineumocócica con el cumplimiento del uso de la vacuna neumocócica en el Servicio de Inmunización del adulto mayor del Centro de Salud Breña Lima 2025	HIPÓTESIS GENERAL Hi: Existe una relación estadísticamente significativa del nivel de conocimiento con el cumplimiento del uso de la vacuna neumocócica en el Servicio de Inmunización del adulto mayor del Centro de Salud Breña Lima 2025 H0: No hay relación significativa del nivel de conocimiento con el cumplimiento del uso de la vacuna neumocócica en el Servicio de Inmunización del adulto mayor del Centro de Salud Breña Lima 2025 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS H1: Existe relación estadísticamente significativa del nivel de conocimiento en su dimensión definiciones de la vacuna antineumocócica con el cumplimiento del uso de la vacuna neumocócica en el Servicio de Inmunización del adulto mayor del Centro de Salud Breña Lima 2025 H2: Existe relación estadísticamente significativa del nivel de conocimiento en su dimensión esquema de Inmunizaciones de la vacuna antineumocócica en el adulto mayores con el cumplimiento del uso de la vacuna neumocócica en el Servicio de Inmunización del adulto mayor del Centro de Salud Breña Lima 2025 H3: Existe relación estadísticamente significativa del nivel de conocimiento en su dimensión medidas ante las reacciones adversas de la vacuna Antineumocócica con el cumplimiento del uso de la vacuna neumocócica en el Servicio de Inmunización del adulto mayor del Centro de Salud Breña Lima 2025	VI = Nivel de conocimiento V2 = Cumplimiento del uso de la vacuna neumocócica	Tipo y nivel de investigación Enfoque: Cuantitativo Tipo de investigación: Aplicado Diseño de investigación: No experimental. De corte: Transversal. Nivel de investigación: Descriptivo correlacional. Población: La población total de estudio fue de 180 adultos mayores. El estudio seleccionará sistemáticamente al azar a 144 adultos mayores del Centro de Salud Breña.

Validación del instrumento

I. DATOS GENERALES:

- 1.1. Apellidos y Nombres : Mori Castro Jaime Alberto
 1.2. Cargo e institución donde labora: Universidad Norbert Wiener
 1.3. Tipo de Experto: Metodólogo () Especialista (x) Estadístico ()
 1.4. Nombre del instrumento motivo de evaluación: Encuesta
 1.5. Autor de instrumento: **Jimmy Jorge Torres Bellido**

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN:

Informe de Opinión de Experto

INDICADORES	CRITERIOS	Deficiente	Regular	Buena	Muy Buena	Excelente
		00 – 20%	21 - 40%	41 - 60%	61 - 80%	81 -100%
CLARIDAD	Esta formulado con un lenguaje claro.					97 %
OBJETIVIDAD	No presenta sesgo ni induce respuestas.					97 %
ACTUALIDAD	Está de acuerdo a lo estipulado.					97 %
ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica y coherente de los ítems.					97 %
SUFICIENCIA	Comprende aspectos en calidad y cantidad.					97 %
INTENCIONALIDAD	Adecuado para establecer relación entre las variables.					97 %
CONSISTENCIA	Basados en aspectos teóricos y científicos.					97 %
COHERENCIA	Entre los índices e indicadores.					97 %

METODOLOGIA	La estrategia responde al propósito de la investigación cualitativa.					97 %
-------------	--	--	--	--	--	------

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD:

Aplicable y adecuado al caso en concreto (Resulta viable a la investigación)

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN

97 %

Lima, 15 de agosto del 2025



Mg. Jaime Alberto Morí Castro
Grado: Maestría en Ciencias
DNI: N.º 07537045

Validación del instrumento

V. DATOS GENERALES:

- 1.1. Apellidos y Nombres : : Molina Torres Jose Luis
1.2. Cargo e institución donde labora: Universidad Norbert Wiener
1.3. Tipo de Experto: Metodólogo () Especialista (x) Estadístico ()
1.4. Nombre del instrumento motivo de evaluación: Encuesta
1.5. Autor de instrumento: **Jimmy Jorge Torres Bellido**

VI. ASPECTOS DE VALIDACIÓN:

Informe de Opinión de Experto

INDICADORES	CRITERIOS	Deficiente	Regular	Buena	Muy Buena	Excelente
		00 – 20%	21 - 40%	41 - 60%	61 - 80%	81 -100%
CLARIDAD	Esta formulado con un lenguaje claro.					95 %
OBJETIVIDAD	No presenta sesgo ni induce respuestas.					95 %
ACTUALIDAD	Está de acuerdo a lo estipulado.					95 %
ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica y coherente de los ítems.					95 %
SUFICIENCIA	Comprende aspectos en calidad y cantidad.					95 %
INTENCIONALIDAD	Adecuado para establecer relación entre las variables.					95 %
CONSISTENCIA	Basados en aspectos teóricos y científicos.					95 %
COHERENCIA	Entre los índices e indicadores.					95 %

METODOLOGIA	La estrategia responde al propósito de la investigación cualitativa.					95 %
-------------	--	--	--	--	--	------

VII. OPINIÓN DE APLICABILIDAD:

Aplicable y adecuado al caso en concreto (Resulta viable a la investigación)

VIII. PROMEDIO DE VALORACIÓN

95 %

Lima, 18 de agosto del 2025



Dr. Molina Torres, José Gregorio
C.E: 003560692

Validación del instrumento

IX. DATOS GENERALES:

- 1.1. Apellidos y Nombres : Jeannelly Paola Cabrera Espezua
 1.2. Cargo e institución donde labora: Universidad Norbert Wiener
 1.3. Tipo de Experto: Metodólogo () Especialista (x) Estadístico ()
 1.4. Nombre del instrumento motivo de evaluación: Encuesta
 1.5. Autor de instrumento: **Jimmy Jorge Torres Bellido**

X. ASPECTOS DE VALIDACIÓN:

Informe de Opinión de Experto

INDICADORES	CRITERIOS	Deficiente	Regular	Buena	Muy Buena	Excelente
		00 – 20%	21 - 40%	41 - 60%	61 - 80%	81 -100%
CLARIDAD	Esta formulado con un lenguaje claro.					94 %
OBJETIVIDAD	No presenta sesgo ni induce respuestas.					94 %
ACTUALIDAD	Está de acuerdo a lo estipulado.					94 %
ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica y coherente de los ítems.					94 %
SUFICIENCIA	Comprende aspectos en calidad y cantidad.					94 %
INTENCIONALIDAD	Adecuado para establecer relación entre las variables.					94 %
CONSISTENCIA	Basados en aspectos teóricos y científicos.					94 %
COHERENCIA	Entre los índices e indicadores.					94 %

METODOLOGIA	La estrategia responde al propósito de la investigación cualitativa.					94 %
-------------	--	--	--	--	--	------

XI. OPINIÓN DE APLICABILIDAD:

Aplicable y adecuado al caso en concreto (Resulta viable a la investigación)

XII. PROMEDIO DE VALORACIÓN

94 %

Lima, 18 de agosto del 2025



Lic. Jeannelly Paola Cabrera Espezua
Mg: Salud Sexual y Reproductiva
DNI: N.º 48832154